

Hat Yai core · Hat Yai · November 2025

หาดใหญ่ พื้นที่หลัก · หาดใหญ่ · พฤศจิกายน 2568

Candidate research scenario · low confidence · non-operational · not an official warning
ฉากทัศน์วิจัยที่ยังไม่ผ่านการรับรอง · ความเชื่อมั่นต่ำ · ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ · ไม่ใช่คำเตือนทางการ

1 · Priority status

Accepted FPPS and A-E action class are unavailable. This low-confidence candidate is for verification only.

2 · Focus and denominator

Hospital / walking illustration: about 264,045 modelled residents (2020 source). Reporting geometry covers 100.0% of the study AOI. Counts concern AOI intersections, not whole subdistricts or observed victims.

3 · Modelled service access

In the baseline model, about 104,827 residents are within 30 minutes of a candidate hospital on foot; 1,662 have unknown access and 59,602 have no route to this service. These categories use the hospital / walking denominator above. Main-road access has no separately qualified service result; road-graph connectivity does not establish real passability.

4 · Scenario and next check

If the precomputed candidate closure is imposed, about 9,940 residents lose 30-minute hospital access and 24,434 become newly unreachable in this model. The road closure is an assumption, not an observed closure. Check the consequential candidate road links, crossing and hospital entrance/operation against dated local evidence; then compare a plausible open-link alternative before using this for a decision.

5 · Uncertainty and source time

The study event window is 2025-11-01 to 2025-11-30; it is not an observation interval. Candidate scene acquisition: 2025-11-23T23:03:09.290537Z (UTC). Flood-affected population, age equity, facility capacity and current passability are not qualified.

Source and scope / แหล่งข้อมูลและขอบเขต: WorldPop modelled residential population; OpenStreetMap candidate roads and destinations; Royal Thai Survey Department / OCHA COD-AB reporting boundaries; Modified Copernicus Sentinel candidate scenario.

Study AOI intersections only. Candidate sites and imposed closures are not surveyed entrances or observed road closures. / เฉพาะส่วนตัดกับพื้นที่ศึกษา จุดบริการและการปิดถนนยังเป็นข้อมูล/สมมติฐานที่ต้องตรวจสอบ

1 · สถานะลำดับความสำคัญ

ยังไม่มีคะแนน FPPS หรือระดับการดำเนินการ A-E ที่ผ่านการยอมรับ กรณีความเชื่อมั่นต่ำนี้ใช้เพื่อจัดลำดับการตรวจสอบเท่านั้น

2 · พื้นที่และตัวหาร

ตัวอย่างโรงพยาบาล / การเดิน: ประชากรที่ประมาณด้วยแบบจำลองราว 264,045 คน (ข้อมูลปี 2020) พื้นที่รายงานครอบคลุม 100.0% ของพื้นที่ศึกษา ตัวเลขเป็นส่วนที่ตัดกับพื้นที่ศึกษา ไม่ใช่ทั้งตำบลหรือผู้ประสบภัยที่สังเกตได้

3 · การเข้าถึงบริการตามแบบจำลอง

ในแบบจำลองฐาน ประชากรราว 104,827 คนอยู่ภายใน 30 นาทีเมื่อเดินไปยังโรงพยาบาลที่ยังเป็นจุดบริการเบื้องต้น; 1,662 คนมีสถานะการเข้าถึงไม่ทราบ และ 59,602 คนไม่มีเส้นทางไปบริการนี้ โดยใช้ตัวหารโรงพยาบาล / การเดินข้างต้น การเข้าถึงถนนสายหลักยังไม่มีผลบริการแยกที่ผ่านการตรวจสอบ ความเชื่อมต่อของโครงข่ายไม่ยืนยันสภาพถนนจริง

4 · ฉากทัศน์และสิ่งที่ต้องตรวจ

หากกำหนดให้ถนนปิดตามฉากทัศน์ที่คำนวณไว้ ประชากรราว 9,940 คนจะเสียการเข้าถึงโรงพยาบาลภายใน 30 นาที และ 24,434 คนจะเข้าถึงไม่ได้เพิ่มขึ้นในแบบจำลอง การปิดถนนเป็นสมมติฐาน ไม่ใช่การปิดที่สังเกตได้ ตรวจสอบถนน จุดข้าม และทางเข้า/การเปิดบริการของโรงพยาบาลที่ส่งผลกระทบหลักฐานท้องถิ่นตามวันเวลา แล้วเปรียบเทียบทางเลือกที่เปิดเส้นทางก่อนใช้ตัดสินใจ

5 · ความไม่แน่นอนและเวลาแหล่งข้อมูล

ช่วงเหตุการณ์ที่ศึกษา 2025-11-01 ถึง 2025-11-30 ไม่ใช่ช่วงเวลาสังเกตการณ์ เวลารับภาพฉากทัศน์: 2025-11-23T23:03:09.290537Z (UTC) ยังไม่ผ่านการรับรองจำนวนผู้ได้รับผลกระทบ ความเท่าเทียมตามวัย ความจุสถานที่ และสภาพถนนปัจจุบัน

Source package SHA-256: 838ca9b47bb833ecf358b9850bb1e06a4834b67e820eb48f07eb64377df60275

Public projection SHA-256: 7af67c78c7e5b43cb62d85431259888af23881bd57760c2c5fb6bd67d6b660e0

Projection catalog SHA-256: 041562b2870f2c970d9d2b0a9f34f5207ca3a05d7fe3149e5a027c7a3ce49771